

Caso	Especialidade	Fármacos Envolvidos	Diagnóstico Original (Safety Agent)	Diagnóstico Correto (Interações e Riscos Identificados)
Caso 1	Cardiovascular / Pulmonary	Heparinized blood, Papaverine-soaked gauze, Protamine	Baixo risco / Sem interação conhecida	Sem interações críticas omitidas. Uso perioperatório padrão com reversão intencional de heparina por protamina.
Caso 2	Cardiovascular / Pulmonary	Marcaïne	Falha na execução do agente	Sem interação medicamentosa. Monoterapia anestésica local para bloqueio intercostal.
Caso 3	Cardiovascular / Pulmonary	Lidocaína 2%, Anticoagulação sistêmica	Baixo risco	Risco leve a moderado de hematoma no sítio de punção. A lidocaína em si não altera a coagulação, mas a punção sob anticoagulação exige hemostasia cuidadosa.
Caso 4	Cardiovascular / Pulmonary	Nenhum fármaco registrado	Dispensado	Sem interações.
Caso 5	Cardiovascular / Pulmonary	Adenosina	Dispensado	Sem interação medicamentosa. Monoterapia para teste de estresse farmacológico.
Caso 6	Cardiovascular / Pulmonary	Nenhum fármaco registrado	Dispensado	Sem interações.
Caso 7	Neurology	Antibióticos, Marcaïne com epinefrina	Baixo risco	Sem interações críticas omitidas. Associação perioperatória padrão segura.
Caso 8	Neurology	Heparina, Prednisona, Depo-Provera, FeSO4, ASA (AAS), Solu-Medrol, Warfarina, Plaquenil	Baixo risco (avaliação incompleta)	Risco crítico de hemorragia grave pelo uso conjunto de anticoagulantes (heparina/varfarina) com AAS, somado ao risco aumentado de úlcera gástrica pela associação de AAS com corticoides.
Caso 9	Neurology	Lanoxin (Digoxina), Capoten, Lasix, KCL, ASA, Voltaren, Alupent, Prednisona	Baixo risco	Risco de arritmia ventricular fatal (Lasix induz hipocalcemia que intoxica a Digoxina), hipercalemia grave (Capoten + KCl) e nefrotoxicidade com perda de efeito anti-hipertensivo (Voltaren + Capoten/Lasix).
Caso 10	Neurology	Opioid analgesics	Dispensado	Risco de toxicidade/tolerância a opioides. Em idosa acamada, altas doses geram alto risco de sedação excessiva, constipação severa e depressão respiratória.
Caso 11	Neurology	Procardia, Lasix, Ecotrin (AAS), KCL, Digoxina, Colace, Coumadin (Varfarina)	Baixo risco	Risco crítico de sangramento intracraniano maciço pela associação de Varfarina (Coumadin) e AAS (Ecotrin) com coagulação já alargada.
Caso 12	Neurology	Haldol, Tylenol, Pamelor (Nortriptilina), Alprazolam/Xanax, Artane, Norvasc, Lorazepam, Lexapro	Baixo risco / Incompleto (0 alertas)	Risco crítico de parada cardíaca por arritmia (prolongamento do intervalo QTc e Torsades de Pointes) pelo uso conjunto de Haldol, Lexapro e Nortriptilina, além de sedação profunda.
Caso 13	General Medicine	ACO oral, DIU, Accutane, Tylenol, Vicodin, Flexeril	Baixo risco	Moderado: Vicodin (Hidrocodona) + Flexeril $\rightarrow$ Sedação aditiva e depressão do SNC. Alerta Clínico: Duplicação de métodos contraceptivos (ACO + DIU) durante o uso de isotretinoína (Accutane).
Caso 14	General Medicine	Nenhum fármaco registrado	Dispensado	Sem interações.
Caso 15	General Medicine	Hidrocodona, Flexeril, Xanax, Neurontin, Propranolol, Oxibutinina, Namenda, Aricept, Morfina, Percocet	Baixo risco / Incompleto (0 alertas)	Antagonismo farmacológico direto (Oxibutinina e Flexeril anulam o efeito do Aricept na demência) e risco de parada respiratória/síncope por excesso de depressores do SNC (múltiplos opioides + Xanax + Flexeril)
Caso 16	General Medicine	Labetalol, Cardizem, Coumadin, Lanoxin, Inderal, MOBIC, Aspirina, Oxazepam, Ibuprofeno, Darvocet-N, Esmolol	Falha na execução do agente	Risco iminente de colapso hemodinâmico e bloqueio cardíaco total pelo acúmulo de diltiazem, múltiplos betabloqueadores e digoxina, além de alto risco hemorrágico (varfarina com vários AINEs).
Caso 17	General Medicine	Albuterol, Digoxina, Teofilina, Prozac, Lasix, Insulinas, Lisinopril, Metoprolol, Nitroglicerina, Zegerid, Simvastatina	Baixo risco / Incompleto (0 alertas)	Inibição enzimática perigosa (Prozac eleva níveis de Metoprolol causando bradicardia severa), risco de arritmia digitálica (Lasix + Digoxina) e antagonismo respiratório (Metoprolol anula o Albuterol).
Caso 18	General Medicine	Mavik, Verapamil, Tarka, Aleve, Tylenol, Tums, Mylanta, Lexapro, Lipitor, Vitaminas, Ocuville	Baixo risco / Incompleto (0 alertas)	Duplicação perigosa de dose (Tarka já contém Mavik e Verapamil), toxicidade muscular por estatina (Verapamil eleva o Lipitor) e risco de sangramento gástrico (Aleve + Lexapro).
Caso 19	Cardiovascular / Pulmonary	Warfarin, Aspirin 100mg	Crítico	Corretamente diagnosticado. Risco elevado de sangramento maior por associação de anticoagulante oral pleno com antiagregante plaquetário.